

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬 骨髄の造血細胞を障害	好中球減少が強い ドセタキセル ドキソルビシン イリノテカン FTD/TPI 血小板減少が目立つ カルボプラチン ゲムシタビン 貧血 シスプラチン カルボプラチン
分子標的薬 造血にも関わる経路を阻害	CDK4/6阻害薬 バルボシクリブ アベマシクリブ PARP阻害薬 オラパリブ ニラパリブ BCR-ABL阻害薬 ダサチニブ イマチニブ
血液がんの治療 強い骨髄抑制・リンパ球減少	多剤併用・細胞療法 R-CHOP ベンダムスチン CAR-T細胞療法 免疫調節薬 レナリドミド ポマリドミド
支持療法 FNの予防・治療・感染予防	G-CSF製剤 フィルグラスチム ペグフィルグラスチム 外来FNの経口抗菌薬 レボフロキサシン アモキシシリン・クラブラン酸 感染予防 ST合剤 アシクロビル

経口薬(保険薬局で交付されることが多い) 注射薬

2 重症度(CTCAE Grade)と保険薬局での対応

軽い — 重症度 — 重い

Grade1	Grade2	Grade3	Grade4
好中球数(/ μ L) 基準値下限未満～1,500	好中球数(/ μ L) 1,500未満～1,000	好中球数(/ μ L) 1,000未満～500	好中球数(/ μ L) 500未満
血小板数(/ μ L) 基準値下限未満～75,000	血小板数(/ μ L) 75,000未満～50,000	血小板数(/ μ L) 50,000未満～25,000	血小板数(/ μ L) 25,000未満
保険薬局での対応 感染予防・体温測定の実践を確認	保険薬局での対応 発熱時の連絡方法を再確認	保険薬局での対応 発熱・出血症状があれば至急連絡 するよう指導	保険薬局での対応 発熱は即受診(FN)、出血に嚴重注 意

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	3週	1か月	3か月～
● G-CSF後の骨痛・腰痛	投与後数日					
● 好中球減少(一般的な化学療法)		7～14日目				
● FNのリスクが最も高い時期		nadir前後				
● 血小板減少(カルボプラチン等)			2～3週目			
● 好中球減少(バルボシクリブ)			各サイクルの後半			
● 回復(次のコースの前)				3週前後		
● リンパ球減少(ベンダムスチン等)					数か月続くことも	
● 貧血(オラパリブ・白金製剤)					数週～数か月で進行	

重篤・特に注意 その他

押さえておきたいポイント

- 好中球のnadirは投与7～14日目。この時期の発熱はFNを疑い、解熱剤で様子を見ずに受診
- FN予防はレジメンのリスクでG-CSFを判断、発熱時は患者のリスクで外来・入院治療を判断
- 発熱時の対応フローの事前共有と、nadir期の電話フォローが薬局の重要な役割